

# TUMORI CUTANATE MALIGNI

---



# AGENDA

---

- CARCINOM BAZOCELULAR
- CARCINOM SPINOCELULAR
- MELANOM



# CARCINOMUL BAZOCELULAR (CBC)

= Tumoră malignă derivată din celulele bazale ale epidermului și celulele nediferențiate ale anexelor sale

- Cea mai frecventă tumoră malignă la populația albă!
- Metastazează extrem de rar
- Are un potențial invaziv local!
- Nu afectează mucoasele
- Bărbați, vârstnici, fototip I-II, zone expuse cronic la soare (față)



# CBC – TABLOU CLINIC

- Debut insidios cu creștere lentă în dimensiuni
- Clinic:

*Formațiune tumorală bine delimitată, cu contur neregulat, cu perle epiteliomatoase la periferie*

*De culoarea pielii, roz-roșie (telangiectazii), brună (melanina)*

*Ulcerează frecvent (observăm cruste hematice pe suprafață)*

*Localizare: pe zone **fotoexpuse**, frecvent la nivelul **feței** și la nivelul pavilionului auricular; mai rar și la nivelul toracelui, mâinilor sau picioarelor*



# CBC NODULAR-ULCERAT



# CBC CHISTIC





# CBC PLAN CICATRICIAL



# CBC TEREBRANT





# CBC SUPERFICIAL



# CBC SCLERODERMIFORM



# CBC PIGMENTAT



# CARCINOMUL BAZOCELULAR (CBC)

- Clinic - Evoluția este lentă, tumora crescând încet pe parcursul mai multor ani.
- Tumora poate avea un caracter invaziv local, cu erodarea structurilor mai profunde, chiar osoase.
- În situații excepționale, tumora poate disemina loco- regional sau poate metastaza limfatic în ganglionii regionali sau sanguin, la nivelul viscerelor

# CBC - TRATAMENT

Profilactic - evitarea expunerii excesive la soare, protejarea, mai ales a feței prin creme fotoprotectoare.

Alegerea – localizare, formă clinică, dimensiune, vârstă, cură radicală, aspect estetic

Standardul de aur – **EXCIZIA** chirurgicală.

- Margine de siguranță – 3-5 mm
- Chirurgie Mohs – localizări periculoase (nazolabial, periocular, scalp, șanț retroauricular), forme clinice (sclerodermiformă)



# CBC - TRATAMENT

Alte tratamente – forme superficiale, sub nivelul gâtului

- Crioterapie, Electrocoagulare
- Radioterapie- pentru formele extensive, agresive
- Chimioterapie: 5-fluorouracil
- Imiquimod
- Terapie fotodinamică

Vismodegib – CBC metastazat, recurent, depășit chirurgical – antagonist al căii de semnalizare Hedgehog

---

# CARCINOMUL SPINOCELULAR



# CARCINOMUL SPINOCELULAR (CSC)

= Tumoră **malignă** care se dezvoltă din keratinocitele stratului spinos, celulele prezentând diferite grade de keratinizare

- Mai rar decât CBC
- Bărbați, 50-70 ani
- Factori predispozanți:

*leziuni precursoare; expunere la UV,*

*radiații ionizante, arsenic sau hidrocarburi aromatice; imunosupresia,*

*cicatrici post-arsură, pos-tulcere cronice de gambă, post-inflamații cronice; factori termici; genodermatoze*

- Mucoase, tegument - zone fotoexpuse
- 1/3 – semimucoasă buză inferioară - + fumat



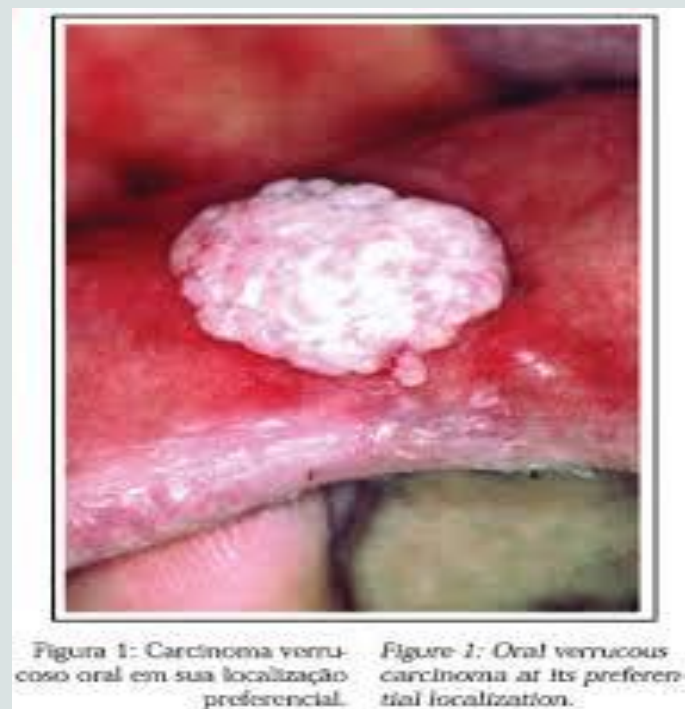
# CSC – FORME CLINICE

- Formă vegetantă – aspect conopidiform, suprafață reliefată, boselată, culoare roz-albicioasă, ulcerare, secreții fetide
- Formă nodulară – placă infiltrată care devine reliefată, nodulară – erodare – cruste hemactice
- Formă ulcerată – mai agresivă, mai invazivă
- Formă verucoasă – genital, bucal, plantar









# CSC – FORME TOPOGRAFICE

- Buză – inferioară, B, expunere solară (cheilită), fumat
- Limbă – B, leziuni anterioare (glosită, lichen atrofic bucal, leucoplazie); infecții HPV, fumat; marginea limbii
- Penis – fața dorsală a glandului, șanț balano-prepuțial; infecții cronice recidivante, fimoze, balanite cronice, lichen scleroatrofic



# CSC – EVOLUȚIE ȘI PROGNOSTIC

- Mai rapid – localizare, grad de diferențiere
- Metastazele – limfatice, mai rar hematic sau perineural – mai frecvent pentru localizările labiale, linguale, peniene, vulvare
- Leziunile genitale, bucale – evoluție rapidă
- Leziunile dorsopalmare – evoluție lentă

# CSC - TRATAMENT

- Profilactic - evitarea expunerii excesive la soare, protejarea prin creme fotoprotectoare; evitarea fumatului
- Standardul de aur – **EXCIZIA** chirurgicală – 3-5mm
- Metastaze – cura chirurgicală a ganglionilor
- Radioterapie – persoane vârstnice, afecțiuni organice;
- Electrocoagulare, chiuretare
- Chimioterapie - paleativ

The background features several stylized, light gray leaf patterns. These include clusters of elongated leaves on stems, as well as single leaves with internal vein-like lines. Two small, solid gray circles are also present, one in the upper left and one in the lower right. A thin horizontal line is located to the left of the text.

MELANOMUL



# DEFINIȚIE

- Tumora malignă derivată din **melanocyte**
- Melanocitele - stratul bazal epidermic / tract uveal, membrane meningeale, mucoase
- Capacitare crescută de metastazare pe cale limfatică / hematogenă

# EPIDEMIOLOGIE

Incidență în creștere în toate țările lumii – 30 ani – 2.9%/an

Sub 5% din totalul tumorilor cutanate, peste 90% din decesele cauzate de acestea

Riscul de a dezvolta melanom – în creștere

- 1 din 1500 persoane născute în 1900
- 1 din 50 persoane caucaziene născute în 2014

# EPIDEMIOLOGIE

- Afectează toate vârstele – vârstă medie: 50 ani
- Afectează ambele sexe - B>F
- Cel mai frecvent cancer la F 25-29 ani (solar)
- Afectează toate rasele - caucaziană

# ETIOLOGIE – FACTORI DE RISC (FR)

## Genetici

- Istoric familial de nevi displazici sau melanom
- Fototip deschis, ochi albaștrii, păr blond/roșcat
- Tendința de a se arde, incapacitatea de a se bronză
- Defecte de reparare a ADN – xeroderma pigmentosum

## De mediu - pot fi influențați

- Expunerea solară intensă, intermitentă
- Arsurile solare / utilizarea solarului
- Rezidență în zone ecuatoriale

## Expresia fenotipică a interacțiunii gene/mediu

- Nevii melanocitari – număr total crescut / nevi atipici / nevi congenitali
- Efelidele
- Istoric personal de melanom

# TABLOU CLINIC

- De obicei asimptomatic
- Se dezvoltă *de novo* / pe leziuni preexistente (25 %)
- Pe zone foto-expuse, ne-expuse, pe mucoase
- Tipic – maculă / papulă / placă / nodul pigmentat
- Mai multe subtipuri – nu prezic independent prognosticul

# MELANOMUL EXTENSIV ÎN SUPRAFAȚĂ MES

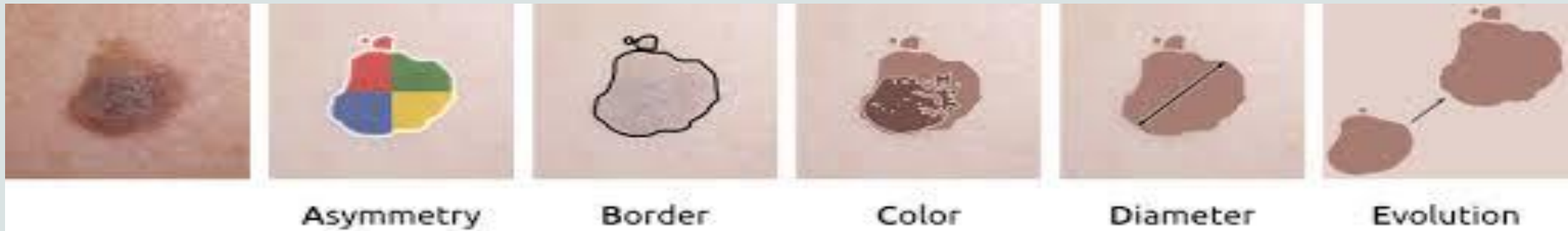
- Cel mai frecvent subtip la persoanele cu fototip deschis – 70%
- 30-50 ani
- Localizare – trunchi (B), membrele inferioare (F)
- Se extinde orizontal (epiderm, derm papilar), ulterior vertical la nivelul dermului





# MELANOMUL EXTENSIV ÎN SUPRAFAȚĂ

- Regula ABCDE



- Maculă asimptomatică, brună/neagră, margini neregulate, diametru >6 mm
- Ulterior – papulă/nodul, regresia (interacțiunea cu sistemul imun)



# MELANOMUL NODULAR

- 15-30 % dintre melanoame
- Decada a șasea de viață
- $B > F$
- Localizare – trunchi, cap, gât
- Creștere mai rapidă, verticală, fără o fază radială
- Nodul negru, albastru, roz-roșu, ulcerat, hemoragic
- Diagnostic – stadii avansate







# MELANOMUL LENTIGO MALIGN LMM

- > 15% dintre melanoame
- Persoane vîrstnice – decada a şaptea de viaţă
- Apare pe piele lezată actinic cronic – faţă (nas, obraz)
- LMM apare pe o leziune precursoră – *lentigo maligna (in situ)* – 5%
- Maculă brună-neagră neuniformă, neregulată, asimetrică, cu margini neregulate, cu creştere lentă





# MELANOMUL LENTIGINOS ACRAL ALM

- 5-10% dinte melanoame
- Cea mai frecventă formă – fototip închis, asiatici
- Persoane vîrstnice – decada a șaptea de viață
- Palme / plante – maculă brună-neagră, neregulată, asimetrică, cu margini neregulate
- Matricea unghială – melanonichie longitudinală, hiperpigmentare care se extinde spre hiponichium sau repliurile unghiale
- Diagnostic - tardiv

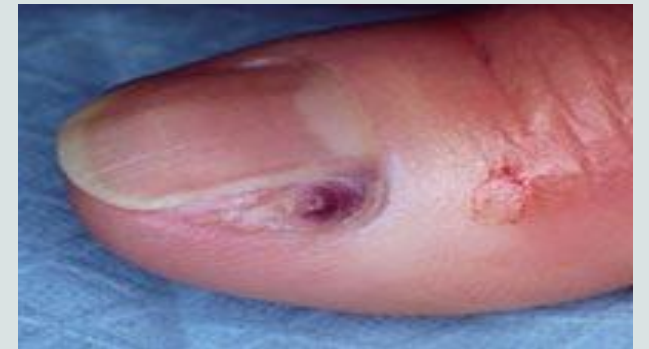






# MELANOMUL AMELANOTIC AM

- Formă de melanom lipsită clinic de pigment melanic – toate tipurile anterioare
- Aprox 5 %
- Diagnostic tardiv – ”marele imitator”
- Leziuni maligne – CBC, CSC, boala Bowen
- Leziuni benigne – psoriazis, dermatite, veruci
- Indiciu diagnostic – E – evoluție





# ALTE FORME DE MELANOM

- Melanomul ocular – rar – conjunctival / uveal



- Melanomul mucoaselor - bucală, nazală, esofagiană, intestinală,



extin



prognostic



# DIAGNOSTIC CLINIC

- Anamneză – APP, AHC, arsuri solare, evoluție (formă, dimensiune, culoare), leziune pre-existentă
- Examinarea întregii suprafețe corporale – pliuri, scalp, mucoase, palme/plante
- Examinarea ganglionilor limfatici, țesutului subcutanat, abdomenului
- Tumora primară – regula ABCDE – nu MN, AM

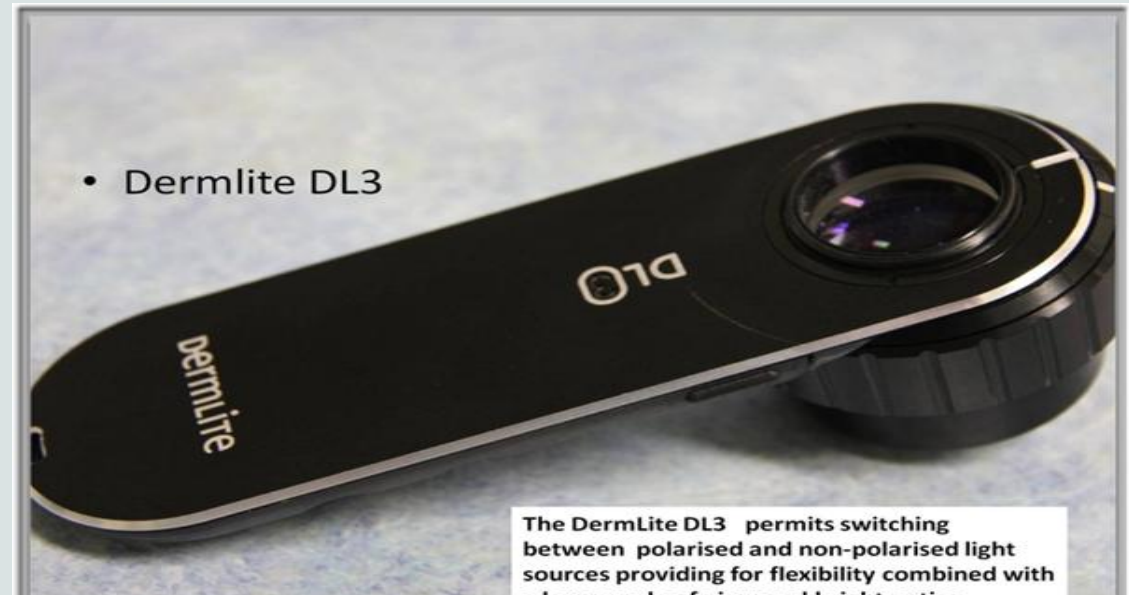


# DERMATOSCOPIA

- Tehnică non-invazivă de diagnostic care utilizează mărirea optică (10X) – integrată în examinarea clinică a leziunii
- Crește acuratețea diagnostică cu 30%



The Heine delta 20 also uses non-polarised light and should be used with an immersion Fluid in contact with the lesion



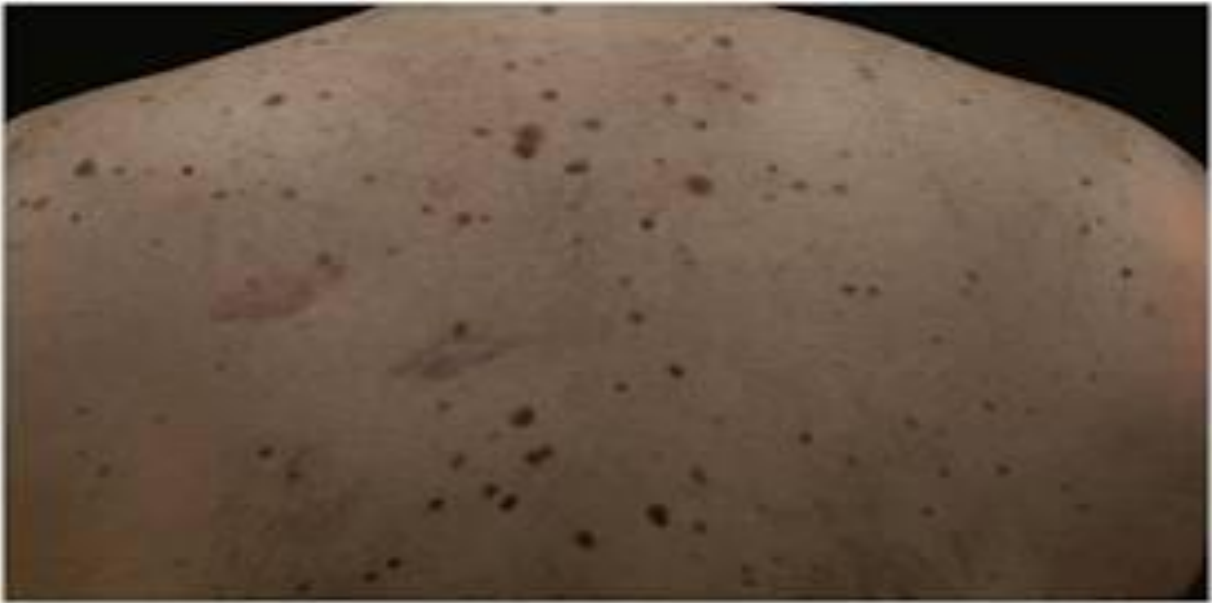
• DermLite DL3

The DermLite DL3 permits switching between polarised and non-polarised light sources providing for flexibility combined with







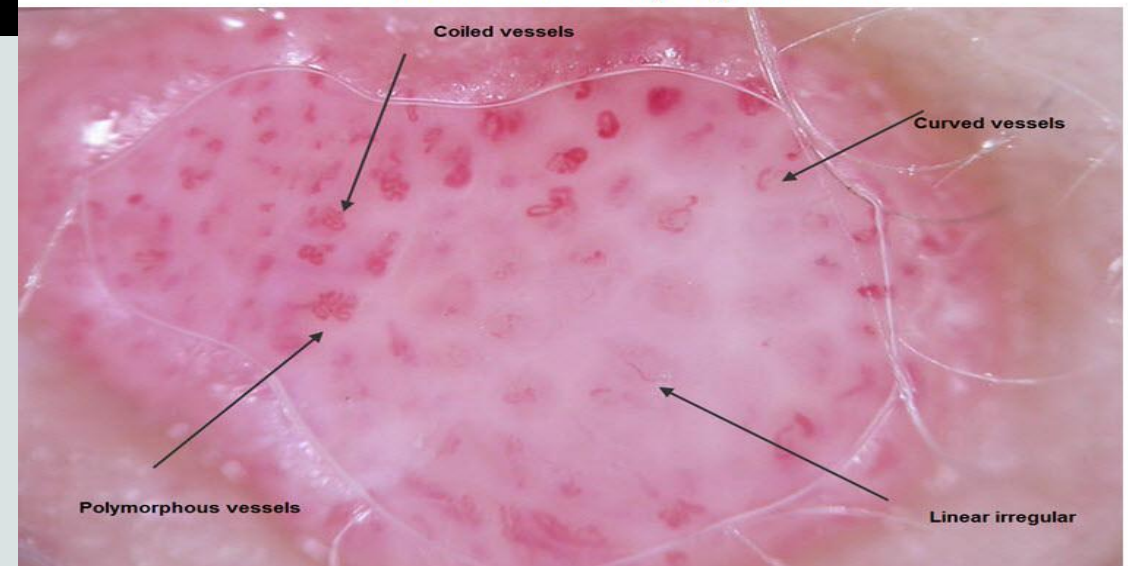








**Amelanotic Melanoma – Polymorphous vessels**



**This amelanotic melanoma has polymorphic vessels but only a very few dot vessels. Often you see more dot vessels.**



# ABORDAREA TERAPEUTICA

## EXCIZIA LEZIUNII

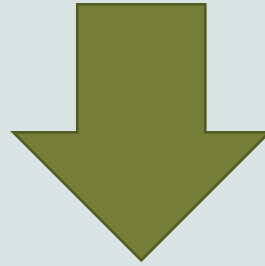
- **Biopsia excizională – cu 1-3 mm margine de siguranță**
- Biopsia incizională – arii anatomice particulare (față, palme/plante, degete, ureche) sau leziuni foarte mari
- Shave-excizia – grad de suspiciune scăzut

Examenul **histopatologic** - Standardul de aur în diagnostic



# DIAGNOSTICUL FINAL

Date clinice + Examen histopatologic



**Stadializarea** inițială – TNM – esențială pentru stabilirea prognosticului și terapiei

Efectuarea ganglionului santinela si reexcizia cicatricii in functie de grosimea IB



# STADIALIZARE - T

Grosimea / indicele Breslow

- T1 - <1mm
- T2 – 1.01-2.0 mm
- T3 – 2.01-4.0 mm
- T4 - > 4 mm

a/b – absența/prezența ulcerăției

# STADIALIZARE - N

Numărul ganglionilor afectați (micro/macrometastaze)

- N1 – 1 ganglion afectat
- N2 – 2-3 ganglioni
- N3 – 4 sau mai mulți ganglioni metastatici; metastaze în tranzit / satelite

Evaluarea ganglionară

- Examen clinic
- Ecografic ganglionară
- Tehnica ganglionului santinelă – IB 1.01-4.00 mm
- Limfadenectomie totală

# STADIALIZARE - M

## Metastaze la distanță

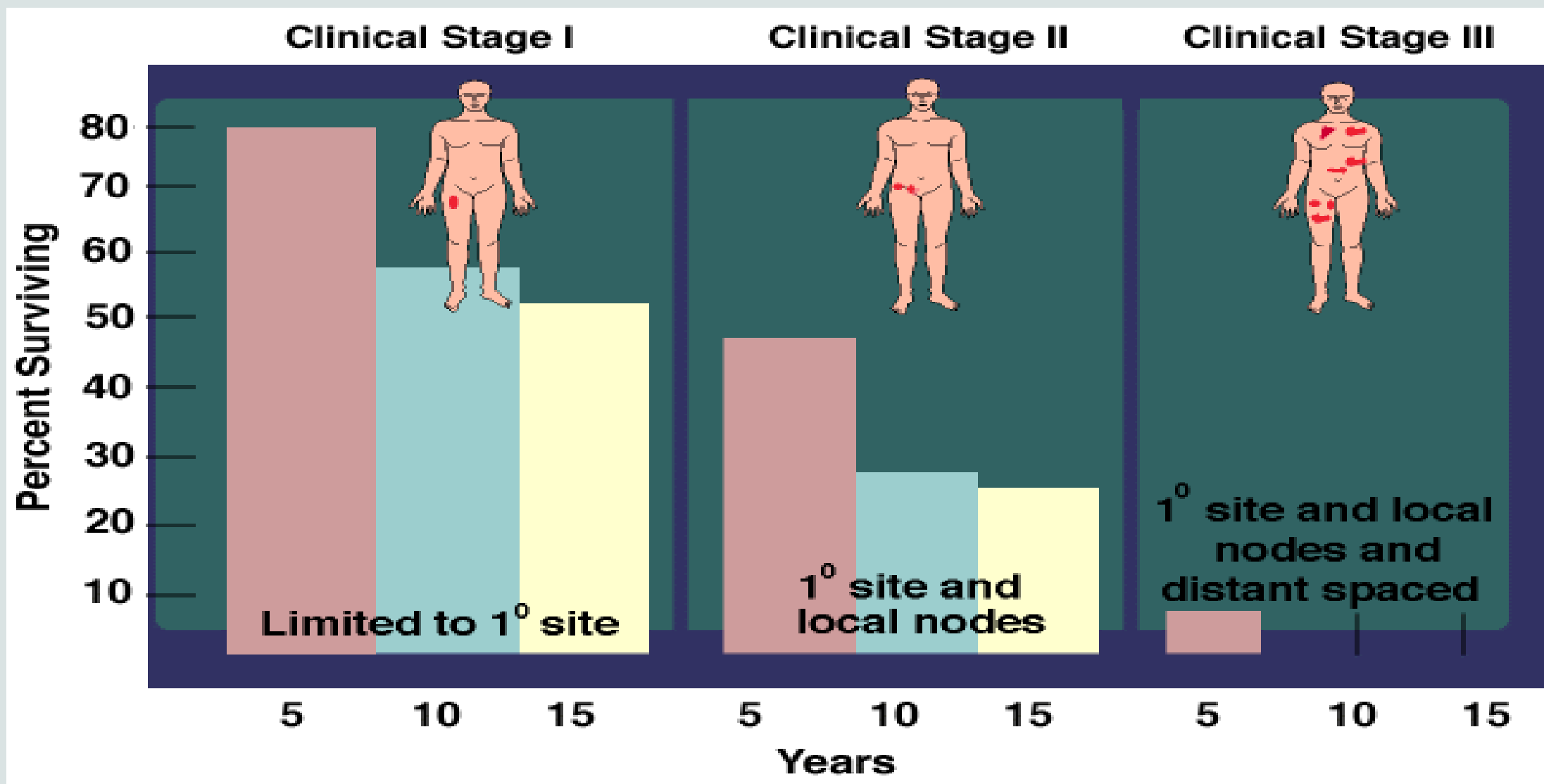
- M1a – metastaze cutanate, subcutanate sau ganglionare la distanță + LDH normal
- M1b – metastaze pulmonare + LDH normal
- M1c – alte metastaze viscerale + LDH normal / orice metastaze la distanță + LDH ridicat

## Evaluarea prezenței metastazelor

- Examen clinic
- Evaluare bio-umorală: proteina S100, LDH
- Ecografie abdominală
- Radiografie toracică/osoasă
- Scintigrafie osoasă/hepatică
- CT, RMN, PET-CT



# EVOLUȚIE ȘI PROGNOSTIC - DEPENDENTĂ DE STADIUL IN MOMENTUL DIAGNOSTICULUI



# EVOLUȚIE ȘI PROGNOSTIC

Factorii de prognostic independenți

- Indice Breslow (**grosimea** in mm), ulceratie, indice mitotic
- Vârsta
- Sex
- Localizare (cap, trunchi)
- Afectare ganglionară
- Metastaze la distanță – localizare (orice organ)

Markeri serici – LDH, S-100, MIA

# TRATAMENT – BOALĂ LOCALIZATĂ – STADIUL I-II

- Tumori primare – excizie chirurgicală

| Tumor Thickness | Recommended Clinical Margins |
|-----------------|------------------------------|
| In situ         | 0.5 – 1 cm                   |
| $\leq 1.0$ mm   | 1.0 cm                       |
| 1.01 - 2 mm     | 1 – 2 cm                     |
| 2.01 – 4 mm     | 2.0 cm                       |
| > 4 mm          | 2.0 cm                       |

- Recurențele locale - excizie

# TRATAMENT – BOALĂ REGIONALĂ – STADIUL III

- Excizia tumorii primare
- Limfadenectomie
- Terapie adjuvantă – eliminarea metastazelor clinic inaparente
  - Interferon- $\alpha$  3x3-10 MU sc /                      săptămână
  - Ipilimumab/ Nivolumab

# TRATAMENT – METASTAZE LA DISTANȚĂ – STADIUL IV

- Chirurgical – in tranzit, cerebrale, pulmonare, GI, țesuturi moi, osoase dureroase
- Radioterapie
- Terapia sistemică – standardul de aur – chimioterapie, imunoterapie, terapii țintite (mutații genetice)

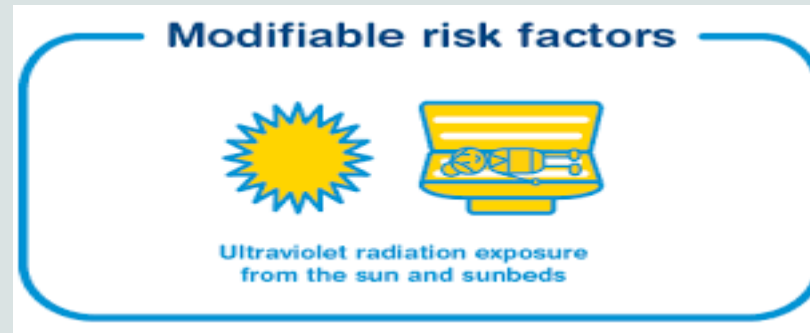


# URMĂRIREA PACIENTULUI

- Identificarea precoce a recurențelor / metastazelor
- Inițierea precoce a terapiei
- Identificarea precoce a unei noi tumori primare (4-8%)
- 3, 6 luni, apoi anual – toată viața

# PREVENȚIA MELANOMULUI

- Controlul factorilor de risc



- Identificarea persoanelor cu risc crescut – auto-examinare, urmărire clinică și dermatoscopică



# CONCLUZII

- Melanomul este o formă agresivă de cancer, care poate afecta toate vârstele, curabil doar în stadiile incipiente
- Educația pacientului este esențială în prevenție
- Examinarea întregii suprafețe corporale ar trebui să fie parte integrantă a examenului obiectiv general
- Regula ABCDE – identificarea leziunilor suspecte
- In caz de suspiciune de melanom - dermatolog